

ΧΗΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ – ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Αίτια: Τραύμα, ξένα σώματα, φακοί επαφής. Τα πιο συνήθη είδη των χημικών ουσιών που προκαλούν οφθαλμικό έγκαυμα, είναι: ασβέστης, τσιμέντο, αμμωνία, χλωρίνη, καθαριστικά κουζίνας, καυστικό νάτριο (*καθαριστικό των αποχετεύσεων*) και καυστικό κάλιο. Σύννηθες έγκαυμα είναι αυτό από το θειικό οξύ (*μπαταρίες*). Η έκταση και το βάθος των βλαβών είναι ανάλογες των ιδιοτήτων του εκάστοτε χημικού, την ποσότητά του και τη διάρκεια της έκθεσης. Αν η διάβρωση οφείλεται σε αλκάλια, τότε το τραύμα είναι βαθύ και χειρότερης πρόγνωσης, αφού προσβάλλονται και οι εσωτερικοί χιτώνες του ματιού. Γενικά, όσο το pH της ουσίας αυξάνει προς αλκαλικό (pH: 9 → 14), τόσο σοβαρότερη η βλάβη του οφθαλμού.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής προσέρχεται συνήθως με οξύ έντονο άλγος, βλεφαρόσπασμο, ερυθρότητα, δακρύρροια, φωτοευαισθησία, μείωση της οπτικής οξύτητας, κ.λπ.

Ελέγχουμε για την ύπαρξη έλκους ή διήθησης στον κερατοειδή. Το έλκος μπορεί να είναι στείρο ή μολυσματικό. Τα μικροβιακά έλκη συχνά είναι εξαιρετικά επίπονα και συνδέονται με τραυματισμό του επιθηλίου του κερατοειδούς, ενώ είναι αρκετά συνήθη στους χρήστες φακών επαφής (*σημ. η κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση*).

Ορισμένοι τύποι μικροβίων, όπως η Ψευδομονάδα, είναι εξαιρετικά επιθετικοί και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη αλλά ακόμη και την τύφλωση εάν παραμείνουν χωρίς θεραπεία για περισσότερο από 24-48 ώρες. Σε βλάβες από τον ιό του απλού έρπητα (HSV-1), το έλκος ή η διάβρωση έχει ακανόνιστη δενδριτική μορφή πάνω στην επιφάνεια του κερατοειδούς.

Οι στείρες (άσηπτες) διηθήσεις προκαλούν λίγο ή καθόλου πόνο. Συνήθως ανευρίσκονται στο περιφερικό τμήμα του κερατοειδούς χιτώνα και δεν συνοδεύονται απαραίτητα από πτώση του επιθηλίου του κερατοειδούς.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε τραυματική διάβρωση ξεπλένουμε καλά το μάτι με άφθονο φυσιολογικό ορό ή R/L και απομακρύνουμε κάθε υπόλειμμα βλαπτικής ουσίας. Μπορεί να χρειαστούν και 8-10 lt υγρών για έκπλυση μέχρι το pH του οφθαλμού επανέλθει στο φυσιολογικό (pH: 7,0).
2. Ενσταλλάσσουμε 2-3 σταγόνες κολλυρίου **Tetracaine** ή **Alcaine 0,5%** για αναλγησία του οφθαλμικού βολβού και για να διευκολυνθούμε στους μετέπειτα χειρισμούς μας.
3. Αφήνουμε 5-7 λεπτά τον οφθαλμό να ηρεμήσει και μετράμε το pH με stick ούρων στον κατώτερο θόλο του επιπεφυκότα. Εφόσον το pH του οφθαλμού δεν έχει επανέλθει στο φυσιολογικό, συνεχίζουμε την έκπλυση και τον καθαρισμό με ορό (N/S ή R/L).
4. Με ειδικό σπρίττο **Φλουοροσκεΐνης** επαλείφουμε την έσω επιφάνεια των βλεφάρων του πάσχοντος οφθαλμού. Αναμένουμε για 1-2 λεπτά και ξεπλένουμε με 10 ml NaCl 0,9%. Προτρέπουμε τον ασθενή να ανοιγοκλείσει τα μάτια, οπότε διαβρώσεις ή υπολείμματα καυστικής ουσίας, με το κυανό φως του οφθαλμοσκοπίου, φαίνονται πρασινοκίτρινα.
5. Χορηγούμε 2 σταγόνες coll. **Tobrex**, 3 φορές την ημέρα (ανά 8 ώρες), για 7-10 ημέρες.
6. Επί υποψίας ή διάγνωσης ερπητικής κερατίτιδας, χορηγείται αντι-ική οφθαλμική αλοιφή **Zovirax 3%**, 5-6 φορές την ημέρα, με επάλειψη στην έσω επιφάνεια του κάτω βλεφάρου.
7. Σε τραύμα από φακούς επαφής και υποψία κερατίτιδας από Ψευδομονάδα, χορηγούμε κολλύρια **Οφλοξασίνης** ή **Σιπροφλοξασίνης** π.χ. coll. **Ciloxan 0,3%**, 2 drops/3h x 14d.
8. Χορηγούμε επίσης, για αναλγησία, κυκλοπληγικά κολλύρια π.χ. coll. Atropine sulf. 1% ή **Κυκλοπεντολάτη** coll. Cyclogyl 1%, (1 σταγόνα, 2 φορές την ημέρα, για 3-7 ημέρες).
9. Σε έγκαυμα από αλκάλι, δίνουμε ανά 6 ώρες κολλύριο Κυστεΐνης ή Ακετυλοκυστεΐνης.
10. Καλύπτουμε τον πάσχοντα οφθαλμό με ελαφρά πιεστική επίδεση (*επίθεμα eye pad*) για 2-4 ημέρες, εκτός των περιπτώσεων βακτηριδιακής ή ιογενούς κερατίτιδας στις οποίες το οφθαλμικό επίθεμα αντενδείκνυται, διότι μπορεί να επιδεινώσει την παρούσα βλάβη.
11. Τα κορτικοστεροειδή πρέπει να αποφεύγονται σε περιπτώσεις μολυσματικών ελκών.
12. Παραπέμπουμε τον ασθενή για επανέλεγχο, σε οφθαλμίατρο, εντός 24-48 ωρών.